

Możliwe ≠ prawdopodobne

Mózg OCD reaguje na **MOŻLIWOŚĆ** jak na **PEWNOŚĆ**. Subiektywne ryzyko 90%, obiektywne 0,000001%. Trzeba je zobaczyć w liczbach.

CZAS: 10 min Przy obsesji kontaminacji, lęku o zdrowie

ŹRÓDŁO: OCCWG (1997); Clark i Beck — model lęku; Foa i Kozak (1986)

JAK UŻYWAĆ

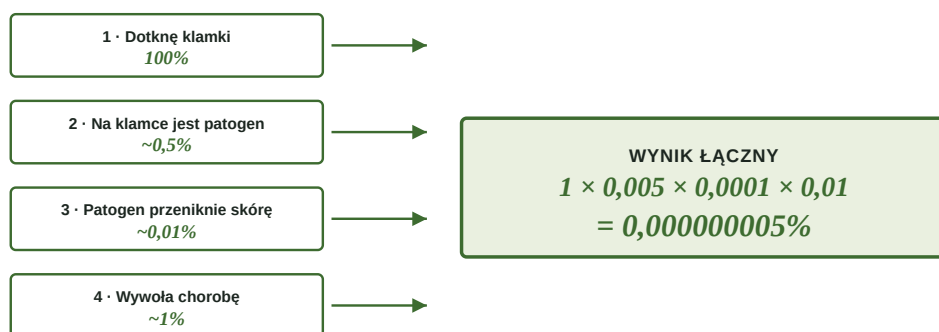
Zmień pytanie z „czy **MOŻLIWE?**” na „czy **PRAWDOPODOBNE?**”. Oblicz **łańcuch prawdopodobieństw**: każdy krok katastrofy ma swoje ryzyko — pomnóż je. Wynik zwykle 0,000001%. Porównaj z akceptowanymi ryzykami codzienności (jazda autem $\approx 1:10\ 000$ /rok). *Downward arrow*: „co najgorszego? I potem?” — kończy się na „przeżyję”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Przecenianie zagrożenia (ang. *threat overestimation*; OCCWG, 1997) to **tendencja do przeceniania prawdopodobieństwa i powagi** zagrożeń. Jedna z 6 kluczowych domen przekonań OCD, **szczególnie silna** w OCD kontaminacyjnym i lęku o zdrowie. Pacjent reaguje na **MOŻLIWOŚĆ** jak na **PEWNOŚĆ**. Subiektywne prawdopodobieństwo zdarzenia katastroficznego: 50–90%. Obiektywne: zwykle $< 0,001\%$. To napędza kompulsje czyszczenia, sprawdzania i unikania, bo **każda możliwość** jest traktowana jako realne zagrożenie. Mechanizm pracy: **łańcuch warunkowych prawdopodobieństw** urealnia szacunki, **strzałka w dół** ujawnia, że „katastrofa” jest do przeżycia.

01 🔍 Łańcuch prawdopodobieństw — przykład

Obsesja: „dotknę klamki → zachoruję na poważną chorobę”. Aby ta katastrofa się spełniła, **każdy** z poniższych kroków musi nastąpić. Pomnóż prawdopodobieństwa.



Porównanie: ryzyko wypadku samochodowego w ciągu roku $\approx 1 : 10\ 000 = 0,01\%$ — czyli **2 miliony razy wyższe** niż obliczone ryzyko z klamki. A jednak wsiadasz do auta.

02 ☉ Strzałka w dół (*downward arrow*) — co dalej

Drugi mechanizm pracy: zamiast obliczać prawdopodobieństwo, zapytaj: „i co najgorszego się stanie?”. Powtarzaj pytanie, aż dojdiesz do dna. Większość katastrof OCD **kończy się na „przeżyję, ale będzie trudno”** — nie na śmierci.

KROK 1 „Nie sprawdzę zamka”. I co najgorszego?

KROK 2 „Złodziej wejdzie, ukradnie rzeczy”. I co najgorszego?

DNO „Trudno mi będzie, ale przeżyję. Ubezpieczenie pokryje. Życie idzie.”

03 Twój łańcuch prawdopodobieństw

MOJA OBSESJA TYPU „A → KATASTROFA”

— konkretna

SUBIEKTYWNE PRAWDOPODOBIENSTWO

— jak czuję %

OBIEKTYWNE DANE

— sprawdź statystyki

KROK KATASTROFY — CO MUSI SIĘ STAĆ?

PRAWDOPODOBIENSTWO (%)

Wynik łączny (iloczyn):

04 Akceptowane ryzyka — porównanie

Wypadek samochodowy w ciągu roku — ~ **1 : 10 000**
= 0,01%

Śmierć od uderzenia pioruna — ~ **1 : 1 000 000** =
0,0001%

Wygrana w totalka — ~ **1 : 14 000 000** =
0,000007%

Atak rekina — ~ **1 : 11 500 000** = 0,000009%

Pytanie: czy podejmujesz akcję ostrożności *przed każdym wypadkiem samochodowym* (1 : 10 000) tak **intensywną**, jak przed katastrofą OCD (1 : miliard)? Jeśli nie — to *asymetria oceny*.

Klucz: Foa i Kozak (1986): pacjenci z OCD **nie potrafią** samo-skorygować szacunków ryzyka *bez ekspozycji*. Sama restrukturyzacja poznawcza daje słabszy efekt niż ERP. Klucz: **analiza łańcucha + ekspozycja** razem. Łańcuch przygotowuje mózg, ekspozycja zapewnia *dane behawioralne*: „dotknąłem klamki 30 razy — i nie zachorowałem”. Łącz z *tolerancją niepewności* — bo nawet po obliczeniu zostaje pytanie „*ale a co, jeśli...?*”. **Praca z niepewnością jest niezbędna.**